

SOLANGE SILMARA PINTO DE MACEDO

MEDICAMENTOS:	AUC seg. / HAS. / DM / colesterol		
SINTOMAS/QUEIXAS	Glifage (2x) / Simvastatina (40mg) / Rivastigmina / Fludacel		
BANHEIRO	2x / atualmente 0x.		
HORA QUE ACORDA	5hrs / 5h depois volta até 12hrs.		
HORA QUE DORME	21:30ms. / 22:30		
PRATICA EXERCICIO	Hidroq. / caminhada		
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES			
CAFE:	ALMOÇO:	LANCHE:	JANTA:
28/06	P= 5.0 cm/H ₂ O		
22	IAH= 4.2/e		
	M. de uso: 5h20'		
	Bem adaptado		
12/07	P= 5.0 cm/H ₂ O		
22	IAH= 1.7/e		
	M. de uso: 5h33'		
	Bem adaptado, porém ainda não acitou - fua		
20/07	P= 5.0		
22	IAH= 4.4		
	M. de uso: 5hr		
	Bem adaptado - fua		
22/08	P= 5.0 cm/H ₂ O		
25	IAH= 2.1/e		
	M. de uso: 4h32'		
	fua		
29/09	P= 5.0		
22	IAH= 3.8/e		
	M. de uso: 4h28'		
	fua		
20/03	P= 5cm/H ₂ O		
23	M. de uso: 4h40'		
	IAH= 4.9 e/e		
	Relata que teve labirintite fua		
15/05	P= 5		
23	M. de uso: 5h44'		
	IAH= 4.8 e/e		
	Euga = 10.7		
31/07	P= 5cm/H ₂ O		
23	IAH= 2.6 e/e		
	M. de uso: 4h45'		
	fua		

04/04
24
P= 5cm/H₂O
IAH= 7.7 e/e
M. de uso: 4h45'

fua

02/06
25

P = 5.6 cmHg

IAH =

M. de uso: 6h30'

fuga = 15.1 epu.

fua.

Nome: SOLANGE SILMARA PINTO DE MACEDO
Data de Nascimento: 4-7-1964
IMC: 29,28
Sexo: Feminino
Data do exame: 28-08-2021

Peso: 65 kg
Altura: 1,49 m
Médico: DR. LUCIANO ROTELLA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 28-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 199,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 13,5 e 34,0 minutos. O tempo total de sono foi de 176,5, eficiência de 88,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,8%; estágio N2: 48,4%; estágio N3: 30,0%; sono REM: 18,7%. O índice de despertares foi de 7,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 26,2/hora, sendo elas 1 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 76 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 84%, permanecendo 22,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 80 bpm e NREM de 61 - 98 bpm.

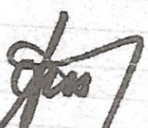
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (03), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame polissonográfico Split-night, na segunda metade da noite para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157



Dr.
Fernando Damião

Diagnóstico e Tratamento da Dor Orofacial (DOF)
e Disfunção Temporomandibular (DTM)

Doa. Ana Cristina

ENCAMUNTO-CHÉ A DACTILITE BLANCO SUCRADA.
PINTO DE MARCADO PARA AVALIAÇÃO DE POSSÍVEL
NO DE CTR.

Obs: Paciente está insatisfeita com relação ao tipo de máscara. A ser usada.

ATL
QMC 20/06/2022

Dr. Carlos Fernando Damiano
CROSP 30.986
CPF 431.803.456-91



(12) 99680-2130



(12) 3923-2130



cdfernandodamiao@gmail.com



@dr.fernandodamiao